



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

INFORME DE LA ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO ADOS-2

Datos de identificación

Nombre: Miguel Francisco Maestre Oñate TI. 1066294950	Escolaridad: 5° grado
Edad: 10 años	Acompañante: Madre (Sorela Oñate)
Fecha de evaluación: 16 Febrero 2026	Fecha de nacimiento: 5 Noviembre 2016

Motivo de consulta: Paciente remitido por neuropediatría por sospecha de TEA para administración de prueba ADOS-2

Problemática actual: Paciente con antecedentes de desbordes conductuales, irritabilidad, enojo y llanto fácil. Con inquietud motora, se distrae con facilidad y se desconcentra.

Cuando niño tenía interés por jugar con los parlantes; buscar por internet carros con parlantes, tiene conocimiento sobre el tema. Cuando niño no tenía juegos simbólicos con sus pares. Antecedentes de no vincularse con sus pares; antes no se integraba, actualmente se integra con niños mayores que él.

Es monotemático. Tiene varios parlantes en su casa.

Antecedentes de no integrarse a los juegos grupales en los cumpleaños, se colocaba al lado del bafle, no interactuaba.

Antecedentes de inflexibilidad ante el cambio; actualmente maneja mejor los cambios.

Antecedentes de conducta autolesiva cuando se enojaba. Es reiterativo con un tema de su interés.

Antecedentes de leer las marcas de los carros a los 3 años y de poca tolerancia al sonido de la máquina de cortar el cabello.

Asiste a terapia con psicología.

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

Técnicas Empleadas:

-) Entrevista semi estructurada

-) **ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO ADOS-2**
Lord. Rutter, Dilavore. Risi, Gothman, S.L. Bishop. Adaptación Española de Luque a TEA Ediciones 2015.

Resultados de la Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo ADOS-2

La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS-2) es una evaluación estandarizada y semi estructurada que evalúa la comunicación, la interacción social, el juego, las conductas estereotipadas, restrictivas y repetitivas. Se aplica a niños, jóvenes o adultos con signos de alarma o sospecha de presentar un cuadro del Espectro Autista. El ADOS-2 se compone por cinco módulos de evaluación, cada uno de los cuales ofrece diferentes actividades estandarizadas que han sido diseñadas para evocar comportamientos relacionados con personas ya diagnosticadas de la misma edad y nivel de lenguaje.

El resultado de la evaluación arroja una clasificación que ayuda al diagnóstico clínico.

Impresión general:

El paciente ingresa a consulta en compañía de su madre; quién luego de la entrevista espera a fuera del consultorio.

Se observó que el paciente establecía contacto visual. Se evidenció atención conjunta e intención comunicativa; sin embargo; el tipo de conversación era unidireccional relacionada con los intereses del paciente.

Hubo pocas muestras de reciprocidad social. El tipo de conversación que se evidenció fue basado en los intereses del paciente con pocas iniciaciones sociales espontaneas por parte del examinado por indagar acerca de los interés o preferencias de la evaluadora.

El feedback conversacional fue limitado, unidireccional, en lugar de una conversación de ida y vuelta.

Se hallaron conductas repetitivas, intereses restringidos durante la evaluación. El paciente fue evaluado usando el ADOS-2, Módulo 3.

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

Resultados cuantitativos ADOS-2 Afectación social y comportamiento restringido y repetitivo

AFECTACIÓN SOCIAL		LENGUAJE FLUIDO
COMUNICACIÓN	Narración de sucesos	1
	Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos	1
	Conversación	1
INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA	Expresiones faciales dirigidas a otros	1
	Disfrute compartido durante la interacción	1
	Contacto visual	1
	Iniciación espontánea de la atención conjunta	1
	Características de las iniciaciones sociales	1
	Cantidad de comunicación social recíproca	1
	Calidad general de la relación	1
TOTAL		9
COMPORTAMIENTO RESTRINGIDO	ÍTEM	
COMPORTAMIENTOS RESTRINGIDOS O REPETITIVOS	Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases	0
	Interés sensorial inusual	0
	Manierismos de manos y dedos y otras estereotipias	0
	Interés excesivo en temas u objetos inusuales o altamente específicos	2
	Comportamiento repetitivo	1
TOTAL		3
TOTAL GLOBAL		12

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

Resultados cualitativos ADOS-2

A continuación, se informará sobre las conductas relevantes para el diagnóstico, observadas durante la administración de la escala ADOS-2.

) Afectación Social: Comunicación e Interacción Social Recíproca

En el ámbito de la comunicación social **se observó contacto visual**.

El paciente mostró un lenguaje verbal manifestado en lenguaje con fluidez verbal, con algunas fallas fonarticulatorias, uso de palabras sofisticadas.

Se evidenció muestras de intención comunicativa; **pero, sus iniciaciones sociales eran dirigidas por los propios intereses del paciente conllevando a una conversación unidireccional**; poco se interesó en generar una conversación teniendo en cuenta los intereses de la evaluadora.

El paciente empezó a hablar de forma espontánea sobre su interés por los carros con sonidos.

Durante sus narraciones, el paciente no generaba oportunidad para que la evaluadora expusiera su punto de vista y tampoco mostró interés por indagar acerca del interés de la profesional. **sus narraciones eran tipo monólogo**, en lugar de generar una conversación recíproca.

Lo anterior demuestra la **dificultad en el paciente para generar feedback conversacional**, en donde tenga en cuenta los intereses del otro e identificar situaciones sociales que permita la fluidez en la conversación respetando turnos sociales.

Al evaluado se le dificulta hacer inferencias a partir de una información social que se le proporciona, así como también comprender la verdadera intencionalidad de los demás.

Se percibió dificultad para entender mensajes implícitos que hay en metáforas o frases con doble sentido, evidenciándose en la interpretación que hizo de una historieta que se le mostró; **el paciente no comprendió el contenido humorístico que tenía la historia y entendió el mensaje literal como lo veía visualmente**. El examinado maneja poca respuesta al sentido del humor y entiende el lenguaje literal tal cual como lo escucha o lo ve.

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

El paciente presenta dificultad para identificar acciones propias que pueden llegar a molestar a los demás; pero sí identifica acciones que hacen los otros que a él le desagradan.

No tiene claro el concepto de amistad y los roles que se deben tener para mantener un vínculo.

A lo largo de la sesión, la conversación fue de tipo unidireccional, puesto que muy poco se evidenció un dialogo de ida y vuelta; ya que el paciente hablaba de sus intereses y no involucraba a la profesional, así como tampoco dio muestras de generar una atención conjunta.

De igual forma **se evidenció dificultad para identificar las reglas sociales convencionales y comprender el lenguaje no verbal del otro.**

Se evidenció dificultad para respetar el turno conversacional.

) **Comportamientos estereotipados e intereses restringidos y repetitivos**

En este ámbito **se observaron conductas repetitivas e intereses restringidos**; durante la evaluación el paciente hablaba del mismo tema (Carros con Sonidos) y muy poco variaba su interés.

Quedaron en evidencia signos de inflexibilidad ante el cambio; cuando se intentaba pasar a un nuevo tema de conversación; el paciente regresaba nuevamente a su tema de interés.

Se observaron conductas repetitivas, durante la evaluación el paciente hacía sonar objetos con sus dedos; se agachaba colocando su oído cerca del sonido.

Su nivel de actividad física durante la sesión fue de **Inquietud Motora**, puesto que no se quedaba quieto cuando la actividad lo requería, no se evidenciaron berrinches, así como tampoco comportamientos negativos o disruptivos a lo largo de la sesión.

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).



Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
3233296257
cohenfontalvo19@gmail.com

Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la escala **ADOS-2 Módulo 3** y relacionándolos con los criterios diagnósticos del manual **DSM-5** para determinar **el nivel de ayuda** se concluye compatibilidad con la clasificación de **Autismo Nivel 1-Necesidad de apoyo**, con afectación para el área social, comunicativa y presencia de patrones de comportamientos inusuales.

Sugerencias

-) Fortalecimiento de habilidades sociales verbales y no verbales
-) Incentivar las actividades compartidas o recíprocas


Sandra Cohen
Neuropsicóloga Clínica
Certificada en ADOS-2
T.P. 122305

Sandra Cohen
Neuropsicóloga clínica
T.P. 122305

"Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil" (A. Einstein).